Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

Rod. BR 101 Sul - Km 80, - do km 82,003 ao km 86,005 - lado ímpar, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54335-000 - F:(81) 31826802

Processo nº **0023171-15.2021.8.17.2810**

AUTOR(A): ANA MARIA FERREIRA DE MELO

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
REPRESENTANTE: PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL

SENTENÇA

Cuida-se de "ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência" ajuizada por ANA MARIA FERREIRA DE MELO em face do ESTADO DE PERNAMBUCO.

Requerendo os benefícios da gratuidade da justiça, a autora narra que é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10 – J84.1), conforme laudo e receita médica no ID 85758090. P. 01/02, necessitando do medicamento NINTEDANIBE 150mg, de 12/12 horas, com 180 comprimidos que durarão por três meses, para tratamento da doença que lhe acomete.

Assim, pugna pelo fornecimento do medicamento pleiteado por tempo indeterminado.

Despacho ID 88761398, em que foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem como determinada a emenda à inicial.

Parte autora juntou aos autos laudo médico solicitado no despacho ID 88761398 (ID 90776666).

Decisão ao ID 98333019 deferiu o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, adquira e forneça à parte autora, ANA MARIA FERREIRA DE MELO, a medicação pleiteada.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Pernambuco ao Id 104455477.

O réu apresentou contestação ao Id 104467803, alegando, preliminarmente, incorreção do valor atribuído à causa. No mérito, defendeu, em síntese, que a CONITEC negou expressamente a incorporação do Nintedanibe ao SUS, por ausência de evidências científicas de sua efetividade para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, não merecendo guarida o pedido da inicial.

Réplica ao ID 112670625.

Despacho ao Id 121576368 intimando a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Pernambuco.

Embargos de Declaração não acolhidos (v. Id. 152458366).

Intimadas para apresentarem novas provas, parte ré pugnou pela solicitação de informações ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário para as demandas de Saúde – NATJUS (v. Id 166575239), ao passo que a parte autora deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

Após a solicitação de parecer ao NATJUS, houve a apresentação da Nota Técnica 278741 com conclusão "não favorável" (v. Id 187937679).

Diante da nota técnica supra referida, a demandante novamente quedou-se inerte, por outro lado, o autor apresentou suas considerações reiterando o pedido de improcedência do pedido (v. Id 196688918).

O Ministério Público pugnou pela improcedência do pleito autoral relativo ao fornecimento do medicamento (v. Id 208292436).

É o relatório, no que de essencial havia para se registrado. Decido.

QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Inicialmente, observo que a demanda versa sobre tratamento contínuo de saúde, devendo ser atribuído à causa o valor dos custos da medicação pleiteada pelo lapso de 12 (doze) meses, conforme previsto no artigo 292, § 2º, do CPC.

Feito esse registro, e diante do laudo médico de Id 85758090 e dos orçamentos apresentados (v. Ids 85758091 e 85758092), verifico que o valor da unidade do tratamento pleiteado é de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), devendo ser atribuído à causa o valor de R$ 228.000,00 (R$ 19.000,00 x 12 = R$ 228.000,00).

Ante o exposto, ao tempo que **ACOLHO** a preliminar, **CORRIJO** o valor atribuído à causa para R$ 228.000,00. **PROCEDAM-SE** às devidas anotações no PJe.

QUANTO AO MÉRITO

Compulsando os autos, observo que a parte autora pretende que o réu seja compelido a lhe fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150mg, o qual não é fornecido pelo SUS.

O referido pleito autoral foi objeto de análise técnica pelo NATJUS, concluindo-se, pelo não fornecimento da medicação pleiteada (Nota Técnica nº 278741 – Id 187937679).

Sobre a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, o Precedente Vinculante RE nº 566.471 (Tema nº 06 de Repercussão Geral):

> Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo . Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1 . O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2 . Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito . Em 2020, o STF

concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5 . A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais . Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados . A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde . A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências . O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: **1 . A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item "4" do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS .** _____ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do

acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min . Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) (grifos acrescidos)

Ademais, o referido julgado motivou a edição da Súmula Vinculante nº 61, cujo enunciado foi assim redigido:

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Feito esses registros, constato que o demandante não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos do item 2 da tese fixada no julgamento do Tema nº 06 de Repercussão Geral, de forma que não é possível a concessão do fármaco pleiteado.

Primeiramente, verifico que o requerente não comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, conforme exigido na letra “b” do item 2 da tese fixada no julgamento do Tema nº 06 de Repercussão Geral. A não incorporação do fármaco para tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) foi objeto da Portaria SCTIE/MS nº 86, de 24 de dezembro de 2018.

Além disso, percebo que o autor também não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar, à luz da medicina baseada em evidências, respaldadas por ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análises, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, conforme exigido na letra “d” do item 2 da tese fixada no julgamento do Tema nº 06 de Repercussão Geral.

Portanto, diante da ausência de provas robustas acerca da eficácia e segurança do medicamento, bem como acerca da eventual ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, ao tempo que **REVOGO** a decisão de ID 98333019, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Caso seja interposto recurso de apelação, independentemente de nova conclusão e despacho:

1. **INTIME-SE** a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal;
2. Interposto recurso adesivo, **INTIME-SE** a parte apelante para apresentar contrarrazões, no prazo legal;
3. Decorrido os prazos estabelecidos nos itens 1 e 2 (se for o caso), **CERTIFIQUE-SE** e **REMETAM-SE** os autos ao e. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Caso não seja apresentado qualquer recurso contra esta sentença, **CERTIFIQUE-SE** o trânsito em julgado e **ARQUIVEM-SE** os autos, independentemente de novo despacho.

CUMPRA-SE.

Jaboatão dos Guararapes, (datado eletronicamente).

Rômulo Macedo Bastos
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ROMULO MACEDO BASTOS
20/08/2025 12:03:27
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 213537859

25082012032772000000207886551

IMPRIMIR GERAR PDF